

La incontinencia urinaria de esfuerzo es el escape de orina cuando algo ejerce presión repentina sobre la vejiga — toser, estornudar, reír, levantar peso o hacer ejercicio. En las mujeres ocurre cuando se debilita el soporte que hay debajo de la uretra, a menudo después del parto o de la menopausia. Es muy común y muy tratable, desde ejercicios sencillos hasta una cirugía rápida y muy eficaz.

## Acerca de esta afección

La **uretra** (el conducto por el que sale la orina) normalmente se mantiene cerrada cuando usted tose o hace fuerza, gracias al soporte del suelo pélvico y a los tejidos que la rodean. Cuando ese soporte se debilita, un aumento repentino de la presión del vientre empuja la orina hacia afuera. La señal característica es **el escape con la actividad** — no con unas ganas repentinas (eso es la vejiga hiperactiva; tener las dos cosas se llama incontinencia **mixta**).

## Qué la causa

- **El embarazo y el parto** (una de las causas principales)
- **La menopausia** y el envejecimiento
- Tos crónica, estreñimiento o levantar peso con frecuencia
- El exceso de peso corporal y cirugías pélvicas previas

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Incontinencia de esfuerzo

Escape de orina con la presión — al toser, levantar peso, hacer ejercicio.

### Uretra

El conducto que lleva la orina fuera del cuerpo.

### Suelo pélvico

Los músculos que dan soporte a la vejiga y la uretra.

### Ejercicios de Kegel

Ejercicios de contracción del suelo pélvico que refuerzan el soporte.

### Incontinencia mixta

Tener escapes de esfuerzo y de urgencia a la vez.

### Pesario / dispositivo

Un pequeño soporte que se coloca en la vagina para reducir los escapes.

### Agente de relleno uretral

Una inyección en consulta que ayuda a que la uretra selle.

### Cabestrillo mediouretral

Una pequeña malla de soporte que se coloca bajo la uretra en cirugía.

**¿NECESITO CIRUGÍA?** No necesariamente. Muchas mujeres mejoran con ejercicios del suelo pélvico y cambios sencillos, y algunas usan un dispositivo de soporte. La cirugía (como un cabestrillo) es muy eficaz cuando quiere una solución más duradera — pero es su decisión, y puede empezar por los pasos más sencillos.

## Cómo se diagnostica

- Una conversación sobre cuándo tiene escapes y un examen (a veces una prueba de tos)
- Un **análisis de orina** para descartar infección, y una revisión de qué tan bien vacía la vejiga
- A veces, una prueba de función de la vejiga (urodinamia) antes de la cirugía

## Cómo se trata (paso a paso)

- 1 **Ejercicios del suelo pélvico** (Kegel) y fisioterapia, bajar de peso y tratar la tos o el estreñimiento.
- 2 **Dispositivos de soporte** — un pesario vaginal o un dispositivo de venta libre.
- 3 **Relleno uretral** — una inyección rápida en consulta que ayuda a que la uretra selle.
- 4 **Cirugía** — un **cabestrillo mediouretral** (o un cabestrillo de tejido propio) para una reparación duradera. Cada opción tiene su propia hoja informativa.

## Vivir con incontinencia de esfuerzo

- Aprenda a **apretar antes de toser, estornudar o levantar peso** ("el truco").
- Haga los ejercicios del suelo pélvico a diario — puede tardar de 6 a 12 semanas en notar mejoría.
- Trate el estreñimiento y la tos crónica, que aumentan la presión.

### Llame a su equipo si tiene:

- Ardor, urgencia o **sangre en la orina** (posible infección)
- Escapes también con unas **ganas fuertes** — el tratamiento puede ser distinto
- La sensación de que la vejiga no se vacía

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La incontinencia de esfuerzo en la mujer es el escape con la presión por un soporte debilitado bajo la uretra — común y muy tratable.
2. Las opciones van desde ejercicios del suelo pélvico y un dispositivo de soporte, hasta una inyección de relleno en consulta o un cabestrillo para una solución duradera.
3. Los ejercicios tardan semanas en funcionar; apriete antes de toser o levantar peso. La cirugía es una opción, no una obligación.